

Дентална обществена медицина

гл. ас. д-р Костагин Костадинов, д.м.

2026/2027

Упражнение 1 – въведение в дисциплината

Катедра "Социална медицина и обществено здраве"

Регистрация



Добре дошли!

- 15 упражнения | всяка седмица | 90 мин.
- 15 лекции | всяка седмица | 90 мин.
- Обучението продължава и през лятото
- Лекционен преподавател: проф. Ц. Митева, дм
- **2 колоквиума** – носят бонус точки
- **Изпит** – лятна изпитна сесия

Как ще работим

На упражненията:

- Работа с данни, индекси и епидемиологични показатели
- Обсъждане на казуси от денталната практика
- Кратки задачи и дискусия, а не преразказ на лекцията

Очаквания:

- Редовно присъствие и активно участие
- Подготовка по темата от лекционния материал
- Колоквиумите се пишат в часовете – не се насрочват допълнително

- Конспект за изпита
- Лекции (слайдове) в SharePoint – **основен ресурс за подготовка**
- Личен уебсайт – материали от упражненията
- **Няма официален учебник** по дисциплината

Подготовката за изпита стъпва върху лекционните слайдове и конспекта.

Съдържание

1. Обществено здраве – рамката
2. Дентална обществена медицина
3. Детерминанти и рискови фактори
4. Методи и инструменти
5. Клиницист и специалист по ДОМ
6. Заключение

Обществено здраве – рамката



Какво е общественото здраве?

Winslow (1920), възприето и от СЗО:

Науката и изкуството да се предотвратяват болестите, да се удължава животът и да се промотира здравето чрез **организираните усилия на обществото.**

Три ключови елемента:

- Предотвратяване, а не само лечение
- Организирани, а не индивидуални усилия
- Обществото като обект на грижа

Клиничен и популационен подход

Клиничният подход търси болния човек:

- Кой от пациентите ми има кариес и как да го лекувам?

Популационният подход търси болната популация:

- Защо това население има повече кариес от съседното?
- Какво измества **цялото разпределение** на риска?

Geoffrey Rose (1985): "Болни индивиди и болни популации"

Парадоксът на профилактиката

Rose: Голям брой хора с малък риск дават повече случаи от малък брой хора с висок риск.

В денталната практика:

- Малко деца с много висок риск от кариес
- Много деца с умерен риск – но те са мнозинството
- Повечето нови кариеси възникват в **голямата средна група**

Извод: Само работата с рисковите групи не решава популационния проблем.

Нива на профилактика

Първична – преди болестта:

- Флуорна профилактика, силанизиране, обучение по орална хигиена

Вторична – ранно откриване и ограничаване:

- Профилактични прегледи, скрининг за орален рак

Третична – ограничаване на последиците:

- Протетично лечение, възстановяване на функция и качество на живот

Дентална обществена медицина

Денталната обществена медицина е науката и изкуството да се предотвратяват и контролират оралните заболявания и да се промотира оралното здраве чрез **организирани усилия на общността**.

Това е формата на дентална практика, при която **общността е пациентът**, а не отделният човек.

Орално здраве – съвременно разбиране

FDI (2016): Оралното здраве е многостранно и включва способността да се говори, усмихва, помирихва, вкусва, гъвче, преглъща и да се изразяват емоции – **уверено и без болка и дискомфорт.**

Следствия за нас:

- Оралното здраве не е само “липса на кариес”
- То е част от общото здраве и от качеството на живот
- Измерва се не само клинично, но и чрез самооценка

Защо е нужна тази дисциплина?

Мащаб на проблема (C3O, 2022):

- Около **3,5 милиарда** души в света живеят с орално заболяване
- Нелекуваният кариес на постоянните зъби е **най-разпространеното** заболяване у човека
- Тежкият пародонтит засяга близо 1 милиард души
- Оралният рак е сред най-честите ракови заболявания в света

Извод: Проблем с такъв мащаб не може да се реши от кабинета.

Особености на оралните заболявания

- **Почти универсално разпространение** – засягат практически всички възрасти
- **Кумулативни и необратими** – загубената зъбна тъкан не се възстановява
- **Силно предотвратими** – известни са рисковите фактори и ефективните мерки
- **Скъпи за лечение** – сред най-разходоемките групи заболявания
- **Неравномерно разпределени** – концентрират се в социално уязвимите групи

Съчетанието “предотвратими, но скъпи и чести” прави популационния подход рационален.

Основна цел: Подобряване и поддържане на оралното здраве на населението чрез организирани обществени усилия.

Оперативни цели:

- Намаляване на разпространението и тежестта на оралните заболявания
- Намаляване на неравенствата в оралното здраве
- Осигуряване на равен достъп до дентални грижи
- Рационално използване на ограничените ресурси

1. **Оценка** на оралното здраве на населението
2. **Анализ** на детерминантите и рисковите фактори
3. **Планиране** на дентални услуги според установените нужди
4. **Разработване на политики** и профилактични програми
5. **Промоция на оралното здраве** и здравно обучение
6. **Оценка на ефективността** на проведените интервенции
7. **Защита** на оралното здраве като обществен приоритет

Цикълът на общественото здраве

Оценка → Планиране → Изпълнение → Оценка на ефекта → отново

- Всяка стъпка стъпва на данни, не на впечатления
- Оценката на ефекта често показва, че програмата не работи както е замислена
- Затова програмите се планират с показатели за проследяване **преди** стартирането им

Това е и логиката на повечето задачи в упражненията.

Детерминанти и рискови фактори

Детерминанти на оралното здраве

Индивидуални: възраст, пол, генетични фактори

Поведенчески: орална хигиена, хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, търсене на дентална помощ

Социално-икономически: доход, образование, заетост, местоживее

Системни: достъпност, финансиране, кадрова осигуреност, здравна политика

Колкото по-надолу в списъка, толкова по-малко зависи от отделния пациент.

Общ подход към рисковите фактори

Оралните и хроничните незаразни болести споделят едни и същи рискови фактори:

- **Захар** → кариес, затлъстяване, диабет
- **Тютюн** → пародонтит, орален рак, ССЗ, ХОББ
- **Алкохол** → орален рак, чернодробни заболявания
- **Нездравословно хранене** → кариес, ССЗ, диабет

Практическа изгода: една интервенция срещу захарта работи едновременно за денталното и за общото здраве – вместо отделни програми за всяка болест.

Неравенства в оралното здраве

- Оралните заболявания следват **социалния градиент** – всяка стъпка надолу по социалната стълбица носи по-лошо орално здраве
- Разликите не са само между бедни и богати, а по целия градиент
- Уязвими групи: деца в неравностойно положение, възрастни хора, хора с увреждания, малцинствени общности, хора в отдалечени райони

Внимание: Програма, която достига предимно до информираните и мотивираните, може да **увеличи** неравенството.

Методи и инструменти

Оценка на оралното здраве

Епидемиологични проучвания по методика на СЗО:

- Стандартизирани критерии → сравнимост между държави и във времето
- Индексни възрасти: 5, 12, 15, 35–44, 65–74 г.

Основни индекси:

- **КЕП / DMFT** – кариозни, екстрахирани, пломбирани зъби
- **СРІ** – състояние на пародонта
- Индекси за орална хигиена, флуороза, зъбни травми

Какво измерва един индекс

КЕП на 12-годишна възраст – основният международен показател:

- Отчита натрупания опит с кариес, а не текущата активност
- Позволява сравнение между държави и проследяване във времето
- Цел на СЗО: КЕП ≤ 3 на 12-годишна възраст

Ограничения:

- Не различава нелекуван кариес от лекуван зъб
- Не отчита болка, функция или качество на живот

Три различни неща:

- **Нормативна нужда** – това, което специалистът установява
- **Осъзната нужда** – това, което пациентът усеща и заявява
- **Търсене** – това, за което пациентът реално отива на лекар

Проблемът: Трите рядко съвпадат. Планирането само по търсенето обслужва тези, които вече идват, а не тези, които имат нужда.

Популационни профилактични мерки

Флуорна профилактика:

- Флуорирана вода, сол или мляко; флуорни пасты и лакове

Училищни и общностни програми:

- Силанизиране на постоянните молари при деца
- Обучение по орална хигиена, надзиравано миене

Мерки извън денталния сектор:

- Ограничаване на свободните захари (СЗО: под 10% от енергийния прием)
- Данъчна и регулаторна политика; контрол над тютюна

Организация и финансиране у нас

- **НЗОК** – пакет дентални дейности с различен обхват за деца и за възрастни
- **Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца** – силанизиране и профилактични дейности
- Дентална помощ, заплащана директно от пациента – съществен дял
- Общински и училищни инициативи; неправителствени организации

Въпрос за дискусия: Кой плаща, кой решава и кой остава извън системата?

Клиницист и специалист по ДОМ

Различен обект на работа

Лекар по дентална медицина – клиницист:

- Работи с **отделния пациент**
- Диагностика и лечение на конкретен случай
- Въпросът е: "Какво е нужно на този пациент?"

Специалист по дентална обществена медицина:

- Работи с **общности и популации**
- Оценка на нужди, планиране, политики, програми
- Въпросът е: "Какво е нужно на тази общност?"

Различни методи и мерки за успех

Клиницистът:

- Клиничен преглед, образна диагностика, лабораторни изследвания
- Индивидуален план за лечение
- Успех = здрав, функциониращ и удовлетворен пациент

Специалистът по ДОМ:

- Епидемиологични проучвания, анализ на данни, икономическа оценка
- Програми, законодателство, модели на финансиране
- Успех = подобрени показатели за цялото население

Признак	Клиницист	Специалист по ДОМ
Пациент	Отделният човек	Общността
Основен подход	Лечение и възстановяване	Профилактика и промоция
Метод на оценка	Клиничен презглед	Епидемиологично проучване
Инструменти	Апаратура, материали, техники	Програми, политики, финансиране
Решение	План за лечение	Приоритети и разпределение на ресурси
Резултат	Здраве на пациента	Показатели на популацията
Етичен акцент	Автономност и благодеяние	Справедливост и полза за мнозинството

Допълващи се, а не конкуриращи се роли

- Клиницистът лекува болестта у пациента пред себе си
- Специалистът по ДОМ работи така, че за много хора да не се стигне дотам
- Ефективната дентална система се нуждае и от двете
- ДОМ задава условията, в които практикува всеки клиницист: кой има достъп, кой плаща, кой изобщо стига до кабинета

Обобщение: индивидуална грижа $\leftrightarrow$ обществено здраве

Всеки клиницист е и деец на общественото здраве

Дори без специалност по ДОМ, в кабинета вие:

- Давате съвети за хранене, хигиена и тютюнопушене
- Откривате ранни признаци на орален рак при рутинен преглед
- Участвате в профилактични и училищни програми
- Подавате данни, от които се правят националните оценки
- Решавате как да разпределите времето си между спешните и профилактичните случаи

Разликата е в мащаба, не в ценностите.

Заключение

Ключови послания

1. Оралните заболявания са масови, предотвратими и неравномерно разпределени
2. Денталната обществена медицина работи с **общността като пациент**
3. Целта е по-добро орално здраве чрез организирани обществени усилия
4. Задачите следват цикъла: оценка → планиране → изпълнение → оценка на ефекта
5. Клиницистът и специалистът по ДОМ решават различни части от един и същ проблем

За следващия път

- Прегледайте конспекта – за да знаете накъде вървим
- Влезте в SharePoint и проверете, че имате достъп до лекциите
- Попълнете регистрацията, ако още не сте

Въпрос за размисъл: Ако имате бюджет за една-единствена програма за цялата страна, за какво бихте го похарчили – и как ще докажете, че е сработила?

Благодаря за вниманието!